

УДК:616.65-006.6-07

К.Ш. Нургазиев, М.К.Алчинбаев, Н.С.Нурғалиев, А.Ж.Жылкайдарова
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Нужен ли нам скрининг по раку предстательной железы?

Аннотация. В статье проанализирована встречаемость среди мужчин рак простаты за 2001, 2011 и 2012 годы в РК. Выявлено повышение частоты заболеваемости и смертности от этого заболевания. У больных РПЖ - одно из самых низких показателей 5-летней выживаемости среди всех онкологических нозологий. Всего 32,5% больных переживают 5-ти летний рубеж, так как на протяжении последних 10 лет отмечается высокая запущенность - около 60-70% больных выявляются в III-IV стадиях (в 2010г - 63,3% больных). Надежды сократить число смертей от рака простаты основаны на двух тактиках: ранней диагностике и эффективном лечении болезни в ее начальной стадии. Скрининг РПЖ и выявление заболевания на ранних стадиях экономически эффективнее лечения РПЖ на поздних стадиях.

Ключевые слова: рак предстательной железы, скрининг.

Рак простаты – злокачественная опухоль, развивающаяся в клетках предстательной железы. Начальные стадии этого онкологического заболевания протекают незаметно для самого человека, а запущенные случаи приводят к смерти. Считается, что от момента начала заболевания до появления первых клинических признаков проходит в среднем около 10 лет. В некоторых ситуациях первыми клиническими признаками уже являются метастазы.

Рак предстательной железы (РПЖ) - одна из ведущих причин смерти мужчин пожилого возраста от злокачественных опухолей в мире. По данным различных источников, среди представителей сильного пола всех возрастов от этой болезни умирает каждый десятый, а по некоторым данным - каждый седьмой мужчина. В структуре заболеваемости среди всех ЗН в мире, РПЖ занимает 2-ое ранговое место, в структуре смертности - 6-ое ранговое место. Ежегодно выявляется более 900.000 (903.452 - по данным Globocan, 2008), умирает около 260.000 (258.381 - по данным Globocan, 2008) больных РПЖ.

В Республике Казахстан в 2001 году с впервые в жизни установленным диагнозом РПЖ взято на учет 534 мужчин (3,6 на 100.000 населения), в 2011 г – 835 (4,8 на 100000 населения), а уже в 2012 г - 897 (5,3 на 100000 населения). По частоте встречаемости среди мужчин рак простаты в 2012 году вышел на 4 место среди всех онкозаболеваний. Сохраняется высокая смертность (относительно количеству выявленных больных) среди больных раком простаты, которая в динамике нарастает: в 2001г – 296 человек (2,0 на 100000 населения), а в 2011 г - 407 (2,4 на 100000 населения). Показатель одногодичной летальности у больных РПЖ на сегодняшний день в РК равен 19,5% (т.е. каждый 5-й пациент, с впервые выявленным диагнозом РПЖ, умирает в течении 1-го года). Отношение заболеваемости к смертности у больных РПЖ в РК - 2,05.

Для примера в Европе данный показатель равняется 7,1. Всего на учет состоит 2852 больных РПЖ (на начало 2012 года). Несмотря на то, что это сравнительно не частая онкопатология (в структуре заболеваемости ЗН занимает 14 ранговое место у мужчин), у больных РПЖ – одно из самых низких показателей 5-летней выживаемости среди всех онкологических нозологий. Всего 32,5% больных переживают 5-ти летний рубеж, так как на протяжении последних 10 лет отмечается высокая запущенность - около 60-70% больных выявляются в III-IV стадиях (в 2010г - 63,3% больных) [1]. Из этого становится совершенно очевидным факт, что заболеваемость РПЖ в нашей стране намного выше за счет не выявленного локализованного рака. Надежды сократить число смертей от рака простаты основаны на двух тактиках: ранней диагностике и эффективном лечении болезни в ее начальной стадии. Скрининг РПЖ и выявление заболевания на ранних стадиях экономически эффективнее лечения РПЖ на поздних стадиях. Если опухоль обнаружена на ранней стадии и лечение будет успешным, есть вероятность того, что удастся избежать развития метастазов опухоли.

В мире было произведено 2 крупных мультицентровых рандомизированных исследований скрининга рака простаты: Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial, было проведено в США и European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) в Европе. Необходимо учитывать тот факт, что все исследования проводились на фоне высоких уровней ранней диагностики.

Первые годы активного скрининга РПЖ в США («эра внедрения ПСА») продемонстрировали выраженный рост заболеваемости, что стало отражением выявления большого числа доклинических форм. При сравнении до-скринингового (1987–1992) и скринингового (1993–1997) периода видно, что общая смертность от РПЖ снизилась с 34.000 человек до 19.000. Снижение началось с 1991 года и составило около 0,4% ежегодно, а с 1994 года темп снижения увеличился до 4,1% ежегодно [3]. Достоверно доказан факт снижения выявляемости запущенных форм РПЖ в скрининге, отношение локализованных форм РПЖ к распространенным растет. В США за период с 1991 по 2006 год обнаружение метастатического рака предстательной железы снизилось с 21,6 до 7,0 заболевших на 100.000 мужчин и составляет 12% от всех впервые выявленных случаев [4].

В исследовании European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) отмечено, что после 10 лет наблюдения уровень смертности от РПЖ в группе скрининга был ниже на 30% чем в контрольной группе. Отдел ERSPC в Швеции добился снижения смертности от рака простаты в скрининговой группе за 14 лет наблюдения до 44% среди всех мужчин, и на 77% у мужчин моложе 60 лет [6].

Оба рандомизированных исследования привлекли

большое внимание и вызвали дискуссии. В исследовании PLCO уровень доказательности в экспериментальной группе составил 85% для ПСА, однако заболеваемость РПЖ в экспериментальной группе в первый год достиг 40% и на 6-ой год вырос до 52%, более того, достоверность результатов при биопсии была лишь 40-52%, тогда как в исследовании ERSPC – 86%. Таким образом, исследование PLCO, вероятно так и не сможет ответить на вопрос о том влияет ли ПСА- скрининг на смертность от РПЖ. Как мы видим, в исследовании ERSPC эффективность применения скрининга можно будет по-настоящему осуществить через 10-15 лет последующего наблюдения.

Да, на сегодняшний день развитые страны мира не проводят популяционные скрининговые исследования по раку предстательной железы, так как считается, что экономически это не оправдано. Но, во-первых, нельзя не учесть, что эти страны уже прошли через данный скрининг, что позволило обществу – управленцам-чиновникам, медработникам, и самое главное населению поменять отношение к данной проблеме. Сейчас там развита страховая медицина, которая обязует регулярным медосмотрам населения, включающим раннюю диагностику по онкопатологиям, в том числе и по раку предстательной железы. Поменялось отношение населения к повышению ответственности за свое здоровье, стало понятно, что болезнь легче предупредить или вылечить на ранней стадии, что это экономически более оправдано. Можно ли сравнивать наши страны с этих позиций. Мы думаем, что пока еще нет. Система здравоохранения у нас другая, а сознание народа по отношению к своему здоровью еще не проснулось. На сегодняшний день здравоохранение нашей республики пытается поменять ту ситуацию с запущенностью по выявлению онкопатологий – создаются программы по ранней диагностике, внедряются скрининговые исследования – т.е. государство берет на себя ответственность за здоровье граждан своей страны. Но к сожалению, во-первых нужно время, и во-вторых нужна солидарная ответственность граждан к своему здоровью.

Таким образом, мы считаем, что внедрение программы ранней диагностики/скрининга РПЖ в РК необходимо в связи с:

Высоким уровнем поздней диагностики;

Низкой 5-летней выживаемостью и высокой смертностью;

Доказанным снижением уровнем смертности, с имеющимся риском гипердиагностики (уровень доказательности 1B – ЕАУ, 2010г.).

Это первый скрининг целевой группой которого являются только мужчины. Его внедрение, совместно с широкой информационной кампанией, будет способствовать повышению ответственности мужчин за свое здоровье, онкопороженности и консолидации усилий, направленных на охрану мужского здоровья.

Ожидаемые результаты скрининга РПЖ в РК

- Повышение уровня ранней диагностики. Достоверного изменения структуры заболеваемости следует ожидать не ранее, чем через 5 лет планомерного осуществления программы.

- Рост уровня пятилетней выживаемости. Реального уменьшения смертности от РПЖ можно добиться не менее чем через 10 лет планомерного скрининга.

- В первые годы скрининга увеличение числа пациентов с местнораспространенным и диссеминированным РПЖ и, соответственно, возрастают затраты на их лечение. В

последующем в основном выявляются локализованные формы. Доля локализованных форм РПЖ увеличится с сегодняшних 30-40% до 50-60% и выше, а суммарные затраты на лечение последовательно снизятся.

- При повторных скринингах – тенденция к смещению более благоприятных стадий заболевания и морфологических степеней злокачественности.

- Уменьшение частоты осложнений и инвалидности от рака простаты.

- В последующих турах агрессивный РПЖ встречается реже, чем в 1ом туре .78

- Высокий риск гипердиагностики.

Мы будем продолжать в следующих номерах журнала освещать проблему по раку простаты, связанных как с диагностикой, так и с лечением. Приглашаем читателей к участию в дискуссиях, обмену информацией. Мы рады будем ответить на Ваши вопросы.

Тұжырым

Қ.Ш. Нұрғазиев, М.К.Алчинбаев, Н.С.Нұргалиев,

А.Ж. Жылқайдарова

Қазақтың онкология және радиология ғылыми- зерттеу институты

Бізге қуық асты безі қатерлі ісігінің скринингі қажет пе?

Мақалада ҚР 2001-2011 және 2012 жылдар аралығындағы ер адамдар арасындағы қуық асты безінің қатерлі ісігі. Ауру-сырқаудың жоғары жиілігі және осы аурудан болған өлімдер. Қуық асты безінде қатерлі ісігі бар науқастар- онкологиялық нозологиялар арасында 5 жылдың көрсеткіштері бойынша тірі қалу деңгейі төмен болды. 5 жылдың кезеңде барлығы 32,5% науқастар өмір сүрді, сондай-ақ соңғы 10 жыл аралығында жоғары асқынулар саны - 60-70% құрады, анықталған III-IV сатыдағы науқастар (2010 жылы 63,3%). Қуық асты безінің қатерлі ісігінен өлгендердің санын азайту мақсатында екі тәсіл құрылды: Алдын- ала диагностикалау және аурудың алғашқы сатысында тиімді ем жүргізу. Қуық асты безінің қатерлі ісігіне скрининг және ауруды алғашқы сатысында анықтау, аурудың соңғы сатысында үнемді әсерлі ем жүргізу

Түйінді сөздер: қуық асты безі қатерлі ісігі, скрининг.

Summary

K.Sh. Nurgaziev, M.K.Alchinbaev, N.S.Nurgaliyev,

A.Zh. Zhylkaydarova

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Do we need screening for prostate cancer?

The article analyzes the incidence of prostate cancer among men in 2001, 2011 and 2012 in the Republic of Kazakhstan. The increase of the incidence and mortality from this disease. In patients with prostate cancer - one of the lowest 5 -year survival rate of all cancer diseases. Total 32.5 % of patients experienced a 5- year mark since the past 10 years there has been neglect high - about 60-70 % of patients detected in stage III-IV (in 2010 - 63.3 % of patients). Hopes to reduce the number of deaths from prostate cancer based on two tactics: early diagnosis and effective treatment of the disease in its initial stages. Prostate cancer screening and detection of the disease in the early stages of cost-effective treatment for prostate cancer in the later stages.

Keywords: prostate cancer, screening.